



RUMAH SAKIT  
**PRIMA HUSADA**

**LAPORAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PPK DAN CP TB  
TRIWULAN I**

**RS PRIMA HUSADA MALANG  
TAHUN 2026**

---

**LAPORAN AUDIT MEDIS  
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG**

Laporan Audit Medis di RS Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada Malang

Disusun,  
Oleh ;  
Komite Mutu RS. Prima Husada



**Nuril Maulidatul Qorida, S.KM**

Disetujui oleh,  
Authorized Person



**Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP**

Disetujui,  
Oleh

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



**dr. Resti Lestantini, M.Kes**

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan medis yang bermutu, efektif, efisien, dan aman bagi pasien. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien adalah melalui pelaksanaan audit medis. Audit medis merupakan proses evaluasi sistematis terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan tujuan mengidentifikasi kesesuaian pelayanan terhadap standar, menemukan potensi kesalahan atau kelalaian, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) merupakan instrumen tata kelola klinis yang bertujuan memastikan pelayanan Tuberkulosis (TB) diberikan secara terstandar, efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan evidence based medicine. Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit, setiap pasien TB yang memenuhi kriteria wajib mendapatkan pelayanan sesuai PPK dan didokumentasikan dalam Clinical Pathway.

Audit mutu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan DPJP dan staf medis dalam mengisi Clinical Pathway serta kesesuaian pelayanan dengan PPK sebagai bagian dari Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).

### **1.2 TUJUAN**

Menilai tingkat kepatuhan DPJP dan staf medis terhadap pengisian Clinical Pathway dan penerapan PPK TB sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan.

1. Menilai kelengkapan pengisian Clinical Pathway TB.
2. Menilai kesesuaian pelayanan dengan PPK TB.
3. Mengidentifikasi hambatan pengisian Clinical Pathway.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan mutu.

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Audit dilakukan terhadap seluruh pasien Tuberkulosis yang menggunakan Clinical Pathway selama periode audit.

Unit yang di audit meliputi :

1. Rawat Jalan
2. Rawat Inap
3. IGD (bila ada pasien TB)
4. Rekam Medis
5. Komite Medik
6. Tim TB DOTS

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Indikator Mutu**

| Indikator                               | Standart |
|-----------------------------------------|----------|
| Kepatuhan pengisian Clinical Pathway TB | ≥90%     |
| Kepatuhan penerapan PPK TB              | ≥90%     |
| Kelengkapan dokumentasi rekam medis TB  | ≥90%     |
| kesesuaian tata laksana dengan PPK      | ≥90%     |

**2.2 Metode Audit**

- a. Jenis audit : audit retrospektif rekam medis
- b. Metode sampling : total Sampling / random sampling
- c. Sumber data :
  - Rekam Medis
  - Clinical Pathway TB
  - PPK TB
  - Register TB

**2.3 Sampel**

Seluruh pasien TB yang menggunakan Clinical Pathway Januari – Juni 2026

**2.4 Hasil Audit**

Pelayanan TB Paru dilaksanakn oleh 3 DPJP Paru , yaitu :

| No    | DPJP                     | Jumlah kasus yang di audi | Kepatuhan PPK | Kepatuhan CP |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1.    | dr. Catur Elvi, Sp.P-Onk | 13                        | 100%          | 100%         |
| 2.    | Dr. Andy, Sp.P (K)       | 30                        | 100%          | 100%         |
| Total | 2 DPJP                   | 43 Pasien                 | 100%          | 100%         |

**2.5 Pengukuran Clinical Pathway**

Kepatuhan Pengisian Clinical Pathway TB Paru  
Rumus :

Jumlah Clinical Pathway lengkap

----- ×100%

Jumlah Clinical Pathway yang diaudit

Hasil pengukuran : jumlah CP diaudit : 43 pasien

- CP lengkap : 40 pasien
- CP belum lengkap : 3 pasien

40 ÷ 43 ×100% : 93,02% (dibulatkan menjadi 93%)

2.6 Capaian Indikator Mutu

| Indikator                               | Target | Capaian | Status          |
|-----------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Kepatuhan Pengisian Clinical Pathway TB | ≥95%   | 93%     | Target tercapai |
| Kepatuhan terhadap PPK TB               | ≥95%   | 100%    | Target tercapai |

Analisa

Berdasarkan hasil audit terhadap 43 rekam medis pasien TB Paru, diperoleh bahwa penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) telah mencapai 100%, menunjukkan seluruh DPJP telah memberikan pelayanan sesuai pedoman klinis rumah sakit dan PNPK Tuberkulosis.

Audit pengisian Clinical Pathway menunjukkan tingkat kepatuhan sebesar 93%, Lebih dari target indikator rumah sakit sebesar ≥90%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola klinis telah berjalan dengan cukup baik.

Ketidaksesuaian yang masih ditemukan berupa :

- Paraf DPJP belum lengkap
- Dokumentasi monitoring harian belum terisi seluruhnya
- Penutupan Clinical Pathway belum dilakukan pada saat pasien pulang

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan  | Melakukan sosialisasi kembali mengenai kewajiban pengisian Clinical Pathway TB kepada seluruh DPJP Paru, menetapkan target kepatuhan ≥93%, menyediakan checklist kelengkapan rekam medis sebelum pasien pulang, dan memperkuat monitoring oleh Komite Medik serta Tim PMKP.                                   |
| Do    | Melaksanakan pelayanan sesuai PPK TB dan melakukan pengisian Clinical Pathway secara lengkap oleh DPJP, perawat, dan tenaga kesehatan terkait. Monitoring kelengkapan dilakukan oleh petugas rekam medis sebelum berkas dinyatakan selesai.                                                                   |
| Study | Hasil audit menunjukkan kepatuhan terhadap PPK mencapai <b>100%</b> dan kepatuhan pengisian Clinical Pathway mencapai <b>93%</b> , lebih dari target rumah sakit (≥90%). Ketidak sesuaian yang ditemukan hanya berupa kelengkapan administrasi seperti paraf DPJP dan dokumentasi monitoring harian.          |
| Act   | Memberikan umpan balik hasil audit kepada seluruh DPJP Paru, melaksanakan audit berkala setiap triwulan, melakukan penyegaran mengenai tata cara pengisian Clinical Pathway, serta mempertahankan capaian kepatuhan melalui supervisi rutin dan evaluasi berkelanjutan dalam rapat Komite Medik dan Tim PMKP. |

---

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Audit Kepatuhan Staf Medis terhadap penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) Tuberkulosis (TB) di RS Prima Husada Malang telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi tata kelola klinis, Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Berdasarkan hasil audit, secara umum seluruh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan staf medis telah melaksanakan pelayanan pasien TB sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) yang berlaku di rumah sakit. Kepatuhan terhadap penerapan PPK telah mendukung proses pelayanan yang sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), sedangkan penerapan Clinical Pathway telah memberikan keseragaman dalam tata laksana pasien, meningkatkan koordinasi antarprofesi, serta memastikan pelayanan yang efektif, efisien, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

Hasil audit menunjukkan bahwa indikator kepatuhan telah memenuhi target mutu rumah sakit, sehingga menggambarkan komitmen seluruh tenaga medis dalam menerapkan pelayanan berbasis bukti (evidence-based practice) dan mendukung tercapainya pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan dilaksanakannya audit kepatuhan ini, diharapkan RS Prima Husada Malang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan Tuberkulosis (TB) yang berorientasi pada keselamatan pasien, efektivitas klinis, efisiensi pelayanan, dan kepatuhan terhadap standar profes

#### **3.2 SARAN**

1. Mempertahankan kepatuhan DPJP dan staf medis terhadap penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) TB dengan capaian sesuai target indikator mutu rumah sakit.
2. Melaksanakan audit kepatuhan PPK dan Clinical Pathway secara berkala, minimal setiap triwulan, sebagai bagian dari Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
3. Meningkatkan kompetensi tenaga medis melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembaruan Panduan Praktik Klinis serta Clinical Pathway sesuai perkembangan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan regulasi Kementerian Kesehatan.
4. Memperkuat peran Komite Medik, Tim PMKP, Tim TB DOTS, dan Instalasi Rekam Medis dalam melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, serta pemberian umpan balik terhadap hasil audit.
5. Mengoptimalkan kelengkapan dokumentasi rekam medis dan Clinical Pathway sebagai bukti penerapan tata kelola klinis yang baik serta sebagai eviden dalam survei

---

akreditasi rumah sakit.

6. Melakukan evaluasi terhadap variasi pelayanan (clinical variance), efisiensi penggunaan sumber daya, lama hari rawat (Length of Stay/LOS), serta biaya pelayanan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit.





| GIZI                                         |                                                                                                                                                     |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN                                     | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                     | HARI PENYAKIT                                     |   |   |   |   |   |   | KETERANGAN                                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                     | 1                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                     | HARI DIRAWAT                                      |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                     | 1                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                                                                                                               |
| 1. Pengkajian awal asuhan gizi di rawat inap | 1. Data Subjektif                                                                                                                                   |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | a. Lihat resiko malnutrisi melalui skrining gizi                                                                                                    | ✓                                                 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
|                                              | b. Mengkaji data antropometri, biokimia, fisik/klinis, riwayat makan, alergi makanan serta riwayat personal. asesmen dilakukan dalam waktu 1x24jam. | ✓                                                 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
| 2. Intervensi Gizi                           | 1. Diagnosis Gizi                                                                                                                                   |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | NI-2.1                                                                                                                                              |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | Peningkatan kebutuhan energi expenditure berkaitan dengan hipermetabolisme ditandai dengan adanya benjolan/ benda asing dalam tubuh                 | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ | Sesuai dengan data asesmen, kemungkinan saja ada diagnosis lain atau diagnosis berubah selama perawatan.      |
|                                              | NI-3.1                                                                                                                                              |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | Kekurangan asupan cairan per oral berkaitan dengan demam, muntah, tidak dapat mencukupi kebutuhan ditandai dengan asupan cairan 60% dari kebutuhan  | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
|                                              | Edukasi dan konseling gizi                                                                                                                          |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | Pemberian edukasi dan konseling gizi kepada pasien, keluarga pasien dan penunggu pasien (Care Giver) mengenai diet tinggi energi tinggi protein.    | ✓                                                 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Edukasi gizi dilakukan pada saat awal masuk (pada hari pertama atau kedua) dan atau pada hari ke 4 atau ke 5. |
|                                              | Tata Laksana / Intervensi                                                                                                                           |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | a. Diet TKTP ( makanan lunak atau makanan biasa)                                                                                                    | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ | kebutuhan zat gizi disesuaikan dengan usia dan kondisi klinis pasien.                                         |
|                                              | b. Cukup cairan dari makanan dan minuman                                                                                                            | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
|                                              | Monitoring dan Evaluasi (Monitor Perkembangan Pasien)                                                                                               |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | a. Monitoring asupan makan                                                                                                                          | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | akan dilihat kemajuannya. Monev pada hari                                                                     |
|                                              | b. Monitoring antropometri                                                                                                                          | ✓                                                 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
|                                              | c. Monitoring Biokimia                                                                                                                              | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                     |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | d. Monitoring fisik / klinis terkait gizi                                                                                                           | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ | Mengacu pada IDNT (International Dietetics & Nutrition Terminology)                                           |
|                                              | Hasil                                                                                                                                               |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
|                                              | a. Asupan Makan >80%                                                                                                                                | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ | Status gizi berdasarkan antropometri, biokimia, fisik/klinis.                                                 |
|                                              | b. Asupan Cairan (minum) adekuat                                                                                                                    | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
|                                              | c. Status Gizi Optimal                                                                                                                              | ✓                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | □ | □ | □ |                                                                                                               |
| KE 8IMPULAN :                                |                                                                                                                                                     | Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP : |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
| Nama KaRu                                    | VENI LESTARI PURI P. AMD. GZ                                                                                                                        |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |
| Kategori                                     | PATUH                                                                                                                                               |                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                               |

| FARMA BI                                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KEGIATAN                                            | URAIAN KEGIATAN                     | HARI PENYAKIT                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | KETERANGAN                                              |
|                                                     |                                     | 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |                                                         |
|                                                     |                                     | HARI DIRAWAT                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |
|                                                     |                                     | 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |                                                         |
| 1. Pengkajian Awal Asuhan Kefarmasian di Rawat Inap | 1. Data Subjektif                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |
|                                                     | a. Riwayat Alergi Obat              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
|                                                     | b. Riwayat Pengobatan Pasien        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
|                                                     | c. Riwayat Efek Samping Obat        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
| 2. Intervensi Farmasi                               | 1. Asesmen Farmasi                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | dengan intervensi farmasi yang sesuai hasil Telaah dan  |
|                                                     | a. Telaah Resep                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | b. Rekonsiliasi Obat                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | 2. Edukasi Farmasi                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | Meningkatkan kepatuhan pasien meminum/ menggunakan obat |
|                                                     | a. Informasi Obat                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
|                                                     | Pemberian OAT sebelum makan         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | b. Konseling Obat                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
|                                                     | Konseling ESO OAT dan penanganan    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | Konseling kepatuhan OAT             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | Konseling penggunaan obat inhalasi  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | 3. Tata Laksana/ Intervensi Farmasi |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | Sesuai dengan hasil monitoring                          |
|                                                     | Rekomendasi kapasa DPJP             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
|                                                     | 4. Monitoring dan Evaluasi          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | Dilanjutkan dengan intervensi farmasi yang sesuai       |
|                                                     | a. Monitoring Interaksi Obat        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | b. Monitoring Efek Samping Obat     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | c. Pemantauan Terapi Obat           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | d. Kepatuhan Pasien Minum Obat      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                         |
|                                                     | 5. Hasil                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | Meningkatkan kualitas hidup pasien                      |
|                                                     | a. Terapi Obat Sesuai Indikasi      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
|                                                     | b. Obat Rasional                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                         |
| Pemilihan Antibiotik Rasional                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                                         |
| 6. Ringkasan Pulang                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | kepatuhan minum obat pasien di      |                                                         |
| a. Terapi Obat Pulang                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                                         |
| b. Edukasi Obat Pulang                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                                         |
| <b>KE SIMPULAN :</b>                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |
| <b>Nama KaRu</b>                                    |                                     | APT. RUPIN PURWA NINGRUM, S. FARM   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |
| <b>Kategori</b>                                     |                                     | PATUH                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |
| Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                         |



|                                                   |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                                   | a. Evaluasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Pemantauan Respirasi                              |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| Observasi:                                        |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|                                                   | a. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | b. Monitor pola napas (bradipnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes, biot, ataksik) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | c. Monitor kemampuan batuk efektif                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | d. Monitor adanya produksi sputum                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | e. Monitor adanya sumbatan jalan napas                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | f. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | g. Auskultasi bunyi napas                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | h. Monitor saturasi oksigen                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | i. Monitor nilai AGD                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | j. Monitor hasil x-ray toraks                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Terapeutik                                        |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|                                                   | a. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | Dokumentasikan hasil pemantauan                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Edukasi                                           |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|                                                   | a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                   | b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| KE SIMPULAN :                                     |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| Nama KeRu                                         |                                                                                                     | AFNI NUR A, S. KEP. NS              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| Kategori                                          |                                                                                                     | PATUH                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP : |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <div></div>                                       |                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |

Analisa :

Berdasarkan hasil audit terhadap rekam medis pasien TB Paru, seluruh kasus telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Panduan Praktik Klinik (PPK) dan Clinical Pathway (CP) TB Paru sehingga diperoleh tingkat kepatuhan sebesar **93%**.

Malang, 02 Februari 2026

Ketua Komite Medik

Ketua SMF Penyakit Paru

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An-TI

dr. Andy, Sp. P(K)

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes